EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 80881
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-18 13:14:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: VICTOR HUGO PANES CARRILLO			RUN	: 12.409.986-2
F.Nac	: 05-10-1973	Edad	: 50 AÑOS, 5 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: LOS MONTES 29 ACT. **DB.30.4.21**			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA D	Teléfono	: 956788010		
Fecha Ingreso	: 2024-03-14	Fecha Egreso	: 2024-03-18 13:14:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) Neumonia lobar izquierda en tratamiento
2) Bronquiectasia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente cona tnec descritos, consulta en CAE por cuadro de bronquiectasia exacerbada, en tratamiento ambulatorio con amoxi/Ac Clav, sin respuesta, . Se solicita hospitalizacion para terapia ATB biasociada, sumado a terapia broncodilatadora

Examenes de lab al ingreso -> antigeno SARS Cov 2 (-), glicemia 123; crea 0,5; ac urico 4,4; PCR 155,6; uremia 24; BUN 11; Na/K/Cl 13/3.6/103; Hb/Hcto 12,1; 35,7; Gb 5,3; plaq 324000; aegment 47%; INR 1,04; orina normal,

Paciente HDN estable, afebril, sin requerimiento de O2 suplementario durante toda la estadia, con menor disnea en comparativa a ingreso . Dluresis y deposiciones (-), con buena tolerancia a alimentacion VO.

Examen de lab 16/03 -> C3 133; C4 43,9; GenXpert (-), Gb 6,7; Hb/Hcto 11.9/35.5; plaq 368000; segment 43%; CSB (-), morfologia leucocitos abundantes, celulas epiteliales escasa cantidad

TAC torax 14/03 -> Focos de neumonia en ambos campos pulmonares, adenopatias mediastinicas y en hilio pulmonar

TAC abdomen y pelvis -> Sin hallazgos

Ex fisico -> Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratads, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) crepitantes finos en base derecha
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infecciso: se continuara con terapia ATB establecida, se solicitaran examenes de control 19/03; en vista de negatividad de CSB, pero con descripcion de leucocitos abundates, se volvera a tomar muestra para

corroborar resultado, se realiza traslape a ceftriaxona,. en base a lo anterior, paciente en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

INDICACIONES AL ALTA

1. Hospitalizacion via HODOm
2. Reposo relativo asistido
3. Regimen liviano a tolerancia
4. Ceftriaxona 2 gr al diaEV (4/12)
5. Azitromicina 500 mg al dia VO (4/12)
6. Lansoprazol 30 mg al dia EV
7. Bromuro de ipratropio 2 puff c/8hrs por AC
8. Salbutamol 2 puff c/8hrs por AC
9. Relvar un puff al dia
10. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS
11. Eszopiclona 3 mg al dia VO
12. Pendiente rescate examenes de derivacion
13. Examenes de control 19/03
14. Pendiente toma de CSB
15. KNT motora y respiratoria dos veces al dia
16. CSV c/6hrs

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO